MATÉRIA 10

SINCROTERAPIA CLÍNICA: A APLICAÇÃO PRÁTICA DA SINCROLOGIA

1. DEFINIÇÃO CLÍNICA

A Sincroterapia Clínica é a aplicação direta dos princípios da Sincrologia no ajuste funcional do Estar.

Não é análise.

Não é escuta prolongada.

Não é investigação do passado.

É:

intervenção objetiva para restaurar a coerência do indivíduo no presente.

2. FUNDAMENTO OPERACIONAL

A Sincroterapia parte de um princípio inegociável:

O problema não está na história do indivíduo.

Está na forma como ele está operando o seu Estar.

3. O PAPEL DO FORMANDO COMO TERAPEUTA

O formando deixa de ser um estudante teórico e passa a atuar como:

gestor de coerência existencial

Sua função não é:

ouvir histórias
interpretar traumas
explorar narrativas
Sua função é:
identificar desalinhamentos
aplicar protocolos
restaurar funcionalidade
4. A BASE DO ATENDIMENTO SINCROLÓGICO
🔻 PRINCÍPIO CENTRAL
A cura vem da instrução, não da exposição.
🔻 BASE BÍBLICA
“Que queres que eu te faça?” — Marcos 10:51
A intervenção de Jesus era:
direta
objetiva
centrada na necessidade
5. ESTRUTURA DA SESSÃO SINCROTERAPÊUTICA
1. IDENTIFICAÇÃO DO DESALINHAMENTO
O terapeuta identifica:
onde está o ruído
qual setor está comprometido
Categorias:
desordem física (ambiente)

desregulação emocional
falha espiritual
indisciplina comportamental
2. DEFINIÇÃO DO FOCO ÚNICO
Um problema por vez.
Evita-se:
sobrecarga
dispersão
paralisia
3. APLICAÇÃO DO PROTOCOLO
O terapeuta prescreve:
ação objetiva
mensurável
imediata
4. VALIDAÇÃO
O critério não é o que o paciente sente.
É:
o que ele executa
6. O MEDIDOR DE COERÊNCIA (MC)
O MC é o instrumento clínico central da Sincroterapia.
🔻 FUNÇÃO
Transformar subjetividade em métrica.
🔻 BASE NEUROCIENTÍFICA

O cérebro precisa de medição para ajustar comportamento.
Fonte: Locke & Latham (2002) — Goal Setting Theory
7. FREQUÊNCIA MÉDIA PESSOAL (P11)
P11 = média das 8 áreas de coerência diária
🔻 INTERPRETAÇÃO
Faixa
Status
Diagnóstico
0 – 6.9
CAOS
Falha estrutural
7 – 7.9
CALIBRAÇÃO
Instabilidade
8 – 10
SUSTENTADO
Autossuficiência funcional
8. OS 8 PILARES DE AFERIÇÃO CLÍNICA
O terapeuta avalia diariamente:
Q1 → Ordem visual
Q2 → Disciplina
Q3 → Resposta ao stress (ROI)

Q4 → Execução mínima (+5 min)
Q5 → Paz interna
Q6 → Tempo de recuperação emocional
Q7 → Qualidade da reação emocional
Q8 → Coerência do humor
9. DIAGNÓSTICO SINCROTERAPÊUTICO
O diagnóstico não é baseado em narrativa.
É baseado em:
menor nota funcional
🔻 REGRA
A menor nota revela o ponto de ruptura do sistema.
10. PROTOCOLOS TERAPÊUTICOS
🔻 PROTOCOLO PMCC (CÔMODO-CHAVE)
identifica o ponto físico de desordem
atua como alavanca mental
🔻 PROTOCOLO P+5
ação mínima
execução imediata
quebra de inércia
🔻 PROTOCOLO PM3M
três prioridades
foco em alto impacto
🔻 PROTOCOLO ROI

resposta emergencial
intervenção em momentos críticos
11. GUIA DE AÇÃO CORRETIVA
🔻 DESVIO EMOCIONAL (Q5–Q8)
Intervenção:
pausa
respiração
isolamento de estímulo negativo
🔻 BASE NEUROCIENTÍFICA
Regulação emocional envolve:
córtex pré-frontal (controle)
amígdala (reação)
Fonte: LeDoux, J. (1996)
🔻 DESVIO OPERACIONAL (Q1–Q4)
Intervenção:
ação física imediata
execução mínima
12. A REGRA DA AÇÃO MÍNIMA
Pequena ação > grande intenção não executada
🔬 BASE CIENTÍFICA
Micro-hábitos aumentam aderência
comportamental.
Fonte: BJ Fogg (Stanford University)
13. O PRINCÍPIO DA NÃO-PERMANÊNCIA

A Sincroterapia não promete estabilidade permanente.

🔻 BASE BÍBLICA

“No mundo tereis aflições…” — João 16:33

🔻 INTERPRETAÇÃO CLÍNICA

recaídas existem

desgaste é natural

O objetivo é:

restaurar rapidamente o alinhamento

14. O ACOMPANHAMENTO DE 21 DIAS

🔻 BASE NEUROCIENTÍFICA

Repetição fortalece circuitos neurais.

Fonte: Hebb (1949)

“Neurons that fire together wire together”

🔻 OBJETIVO

consolidar hábitos

estabilizar comportamento

elevar P11

15. NEUROPLASTICIDADE APLICADA

A Sincroterapia atua diretamente sobre:

reconfiguração neural

substituição de padrões

fortalecimento de rotas funcionais

16. ENGENHARIA DO COMPORTAMENTO

O cérebro funciona por:
repetição
associação
recompensa
🔻 INTERVENÇÃO
cortar estímulos nocivos
inserir estímulos saudáveis
reforçar execução
17. ÉTICA DO SINCROTERAPEUTA
O terapeuta:
não cria dependência
não prolonga sessões desnecessariamente
não explora emocionalmente
Ele:
direciona, ajusta e libera
18. POSTURA CLÍNICA
objetividade
firmeza
clareza
ausência de emocionalismo
19. LINGUAGEM TERAPÊUTICA
Evita:
subjetividade
abstração excessiva

Utiliza:
comando
direção
instrução
20. RESULTADO ESPERADO
O paciente não sai:
entendido
acolhido emocionalmente
Ele sai:
funcional
21. DEFINIÇÃO FINAL
Sincroterapia Clínica é:
a engenharia prática da manutenção do Estar, baseada em medição, ação e alinhamento contínuo com a ordem ontológica.
FRASE FINAL
Quem mede, ajusta.
Quem ajusta, governa.